

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy
Coiling/ Embolisation of Intracranial Aneurysm

معلومات الإقرار - نسخة المريض
إغلاق الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة

1. What is a Coiling of an Intracranial Aneurysm?

An Intra-Cranial Aneurysm is an abnormality and weakness in the wall of a blood vessel in the brain.

Coiling (or embolisation) is where tiny coils of soft metal thread or other embolisation material are used to block off the blood flow in the aneurysm.

Filling the aneurysm with coils stops the blood flowing into it, reducing the chance of the aneurysm bursting and bleeding. When coils are inserted into the aneurysm the blood inside the aneurysm clots and prevents any more blood entering it. The coils stay in for life.

Coiling/embolisation are used instead of open surgery to treat aneurysms.

Stents

Depending on the shape of your aneurysm a stent may be required. A stent is a small metal mesh tube that is placed in the artery to help hold the coils inside your aneurysm and prevent them from falling out. Aneurysms that have wide necks usually need a stent. If used, the stent also stays in for life.

The Coiling/embolisation is done by placing a needle and a thin plastic tube (catheter) into the artery in your groin. Iodinated Contrast Media (once called x-ray dye) is used during the procedure to map your arteries so the doctor can locate and treat your aneurysm. If you require more information on Iodinated Contrast Media please request the patient copy for Contrast Media.

2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

This procedure will require both a local and general anesthetic. A pre-anesthesia check up will be performed for the general anesthesia.

3. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- You may be given blood thinning medications to take for a few days before your appointment.
- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

4. During the procedure

A fine needle (IV cannula) will be put into a vein in your arm.

You will be given a general anesthetic.

The Radiologist (x-ray doctor) will inject local anesthetic into

1. ما هو إغلاق الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة ؟
وجود تمدد للأوعية الدموية داخل الجمجمة هو أمر غير طبيعي وموضع ضعف في جدار أي وعاء دموي.

في إجراء إغلاق (سد) الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة يتم استخدام خيوط معدنية لولبية صغيرة ورقيقة لإغلاق تدفق الدم إلى المنطقة الممتدة من الوعاء الدموي.

ملئ التمدد الوعائي بهذه الخيوط يوقف تدفق الدم إلى داخلها ، مما يقلل من انفجار هذا التمدد الوعائي وحدوث النزيف.
عند إدخال هذه الخيوط المعدنية اللولبية إلى داخل التمدد الوعائي ، يحدث تخثر للدم داخل التمدد مما يحد من دخول المزيد من الدم. تظل هذه الخيوط اللولبية مدى الحياة.

تستخدم هذه الطريقة في علاج التمدد الوعائي كبديل للجراحة المفتوحة .

الدعامات

بناء على شكل التمدد الوعائي ، فقد تكون هناك حاجة لدعامات. الدعامات هي شبكة معدنية صغيرة على شكل أنبوب يتم وضعها في الشريان للمساعدة في تثبيت الخيوط المعدنية اللولبية في مكانها داخل التمدد الوعائي ومنع سقوطها. التمدد الوعائي الذي له عنق (فتحة) واسعة غالباً ما يتطلب وضع دعامات. في حالة وضع الدعامات ، فإنها تبقى مدى الحياة.

يتم إغلاق التمدد الوعائي بالخيوط المعدنية اللولبية عن طريق وضع إبرة و أنبوب بلاستيكي رقيق (قسطرة) في شريان بمنطقة أعلى الفخذ . تستخدم مادة الوسط المتباين المعالجة باليود (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) في هذا الإجراء لرسم خريطة لشرايينك مما يمكن الطبيب من تحديد موقع الوعاء الدموي المتمدن وعلاجه.

للمزيد من المعلومات عن مادة الوسط المتباين المعالجة باليود والمخاطر المرتبطة بها ، نرجو قراءة ورقة معلومات المريض المتعلقة بمادة الوسط المتباين المعالجة باليود (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها).

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي وكذلك استخدام التخدير الكلي. إذا كنت ستجري الفحص تحت التخدير الكلي نرجو منك التوجه لقسم التخدير للفحص المسبق.

3. التحضير للإجراء

سيقوم قسم الأشعة والتصوير الطبي بإعطائك تعليمات متعلقة بالتحضير لهذا الإجراء.

- قد تعطى أدوية لزيادة سيولة الدم لتستخدمها لعدة أيام قبل موعد الإجراء.
- نرجو إبلاغ الموظفين المسؤولين عن الإجراء إن كنت حاملاً أو إذا كان هناك أي احتمال بأن تكوني حاملاً .

4. خلال الإجراء

يتم وضع حقنة رفيعة في أحد أوردة ذراعك (خط وريدي).

يتم إعطائك تخدير كلي.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the skin. A needle and catheter are inserted into the artery in your groin; sometimes your arm may be used. Once the catheter is in place the needle is removed.

The catheter is guided through the main blood vessels in your body until it reaches the blood vessels that go to your brain.

X-ray images are taken while the contrast is injected into your arteries.

If required, a stent will be placed in the artery across the opening of the aneurysm. Once the catheter is in place the coils/embolisation material are gently pushed into the aneurysm. They conform to the shape of the aneurysm slowly filling it up. Several coils may be needed to completely fill your aneurysm.

Contrast is injected after every coil is placed to assess your aneurysm. Once the aneurysm is filled with coils the catheter is removed leaving the coils in place.

Firm pressure will be put over the area where the catheter went into your skin (puncture site), sometimes a special plug is used. This allows the artery to seal so you will not bleed.

5. After the procedure

Firstly you will be monitored in the hospital's Intensive Care Unit (ICU) then transferred to the ward. You will need to lie flat and keep your leg (or arm) still and straight for 4 to 6 hours. Moving too soon after the procedure may cause bleeding at the puncture site.

You are encouraged to resume normal daily activities as soon as possible. Staff will discuss with you the level of activity recommended after your coiling.

You may be asked to continue taking blood thinning medications for a few months after your procedure.

You will be required to have follow up imaging procedures (angiograms, MRI and/or CT) to monitor your aneurysm over the next few years.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).

يقوم طبيب الأشعة بحقن مخدر موضعي في الجلد . يتم إدخال إبرة وقسطرة رفيعة في الشريان بمنطقة أعلى الفخذ ، في بعض الأحيان يستخدم وريد في الذراع. تزال الإبرة بعد إدخال القسطرة إلى موقعها المحدد.

تمرر القسطرة داخل الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم حتى تصل الشريان المتجه إلى المخ. تؤخذ صور بالأشعة السينية بينما يتم حقن مادة الوسط المتباين في الشرايين.

عند الحاجة ، يتم وضع دعامة في الشريان عبر (على امتداد) فتحة التمدد الوعائي .

ما أن توضع القسطرة في موضعها المحدد حتى يتم برفق دفع الخيوط المعدنية اللولبية إلى داخل التمدد الوعائي. تقوم الخيوط المعدنية اللولبية بالتمايل والانحناء لتطابق شكل التمدد الوعائي ولكي تملأه ببطء . قد تكون هناك حاجة لاستخدام العديد من الخيوط المعدنية اللولبية لملئ التمدد الوعائي بشكل كامل.

يتم حقن مادة الوسط المتباين بعد إدخال ووضع كل خيط لتقييم التمدد الوعائي . ما أن يتم ملئ التمدد الوعائي بالخيوط المعدنية حتى تتم إزالة القسطرة تاركة الخيوط المعدنية في مكانها المحدد داخل التمدد الوعائي.

يوضع ضغط قوي على الجلد في منطقة دخول القسطرة ، وتستخدم أحياناً سدادة معينة . يؤدي ذلك إلى إحكام إغلاق الشريان لمنع حدوث نزيف من منطقة إدخال القسطرة.

5. بعد انتهاء الإجراء

في البداية ، ستتم مراقبتك في المستشفى في وحدة العناية المركزة ، أو في منطقة الملاحظة العالية ، ثم تنقل إلى وحدة التنويم الاعتيادية.

سيطلب منك الاستلقاء مسطحاً على ظهرك مع إبقاء ساقك (أو ذراعك) ممدودة وفي حالة سكون (ثبات) لمدة 4-6 ساعات. التسرع في الحركة بعد الإجراء قد يسبب نزيف من موضع إدخال القسطرة.

من المهم أن تعود لممارسة نشاطات حياتك اليومية في أسرع وقت . سيناقش معك الموظفون مستوى النشاطات التي يمكنك القيام بها بعد هذا الإجراء.

قد يطلب منك الاستمرار في تناول الأدوية المسيلة للدم لعدة أشهر بعد الإجراء.

سيطلب منك القيام بمتابعة الإجراء الذي خضعت له بواسطة إجراءات التصوير الطبي (التصوير الوعائي ، التصوير بالرنين المغناطيسي وأو التصوير المقطعي المحوسب) لمراقبة التمدد الوعائي ، وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.

6. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين) .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Rupture of the aneurysm causing bleeding in the brain. This can lead to stroke or stroke like complications which can cause weakness in the face, arms and legs. This could be temporary or permanent.
- Stroke caused by constricted blood vessels, blood clots or ruptured artery. This can cause weakness in the face, arms and legs. This could be temporary or permanent.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- Over time, the compressed coils may cause the aneurysm to reform. This may require further coiling or surgical procedures.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Incomplete coiling of your aneurysm. This may require further coiling procedures.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is possible.

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*. Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

7. What are the safety issues when you leave the hospital?

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;

- a cool or cold limb
- slurred speech, balance problems or trouble using your arm or leg

- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية و علاجات أخرى.
- تمزق التمدد الوعائي مسبباً نزيف في المخ. قد يسبب ذلك سكتة دماغية أو مضاعفات مشابهة لتلك الناتجة عن السكتة الدماغية . قد يسبب ذلك ضعف في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
- سكتة دماغية بسبب انقباض الأوعية الدموية ، تخثر دموي أو تمزق الشريان . قد يسبب ذلك ضعف في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
- ضرر للأنسجة المحيطة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- خثرة دموية أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- مع الوقت ، قد يعود التمدد الوعائي للتشكل بسبب انضغاط الخيوط المعدنية اللولبية. قد يتطلب ذلك وضع خيوط معدنية أخرى أو إجراء جراحي.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية(تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- عدم اكتمال ملئ وإغلاق التمدد الوعائي ، مما قد يتطلب إجراء إغلاق أخرى للتمدد الوعائي.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة محتملة بسبب هذا الإجراء.

مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

7. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

توجه لأقرب قسم الطوارئ أو اتصل بطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام أو شعرت بالتالي :

- فتور أو برودة في أحد الأطراف.
- التحدث بشكل غير واضح ، مشاكل في التوازن أو في استخدام الذراع أو الساق.
- ألم لا يختفي بأدوية الألم المعتادة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- pain unrelieved by simple pain killers
 - continuous bleeding or swelling at the puncture site
 - redness or inflammation at the puncture site a fever
- Other warning signs the doctor may have asked you to be aware of.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

- نزيف مستمر أو تورم مستمر في موضع دخول القسطرة.
- احمرار أو التهاب في موضع دخول القسطرة .
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- ملاحظة أيأ من الأعراض التي حذرك الطبيب منها وطلب منك التنبيه لها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
